Revista de Gestión Clínica Simulada · Vol. 3 · 2026

Efecto de un programa de planificación precoz del alta sobre la estancia media y los reingresos a 30 días en un servicio de Medicina Interna

Autores ficticios: A. Martín, L. Soler, J. Ferrer · Hospital universitario simulado

Resumen

Se evalúa un programa de planificación del alta que empieza en las primeras 48 horas del ingreso. Tras seis meses, la estancia media bajó de 9,2 a 8,3 días y los reingresos a 30 días pasaron del 12,8 % al 11,0 %. La satisfacción de los pacientes con la información al alta mejoró.

Introducción

En los servicios de Medicina Interna ingresan pacientes de edad avanzada, con varias enfermedades crónicas y mucha medicación. El alta suele organizarse el último día, lo que genera retrasos, dudas sobre el tratamiento y reingresos evitables.

Métodos

Estudio antes-después en un servicio de 120 camas. Periodo de control: enero a junio. Periodo de intervención: julio a diciembre. El programa incluyó: fecha prevista de alta fijada en las primeras 48 horas, conciliación de la medicación con farmacia, hoja de recomendaciones con lenguaje sencillo y llamada telefónica a las 72 horas del alta. Se analizaron 2.310 ingresos.

Resultados

Indicador	Control	Intervención
Estancia media (días)	9,2	8,3
Reingresos a 30 días	12,8 %	11,0 %
Altas antes de las 12:00	18 %	34 %
Satisfacción con la información al alta (0-10)	6,9	8,1

Limitaciones

Diseño antes-después sin grupo control simultáneo; los periodos comparados corresponden a estaciones distintas del año, lo que puede influir en la actividad. Estudio en un único centro.

Conclusiones

Planificar el alta desde el ingreso se asoció con una estancia más corta y menos reingresos. Se recomienda confirmar estos resultados con estudios multicéntricos.

Referencia

Martín A, Soler L, Ferrer J. Efecto de un programa de planificación precoz del alta sobre la estancia media y los reingresos a 30 días. Rev Gest Clin Simul. 2026;3:45-51. (Referencia ficticia)

ARTÍCULO FICTICIO CREADO PARA UN EJERCICIO DE FORMACIÓN · No es una publicación real · No usar para decisiones clínicas